SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH

Hướng dẫn, tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVNT ngày / /2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân)

Mã: QĐ-C6.2 · Lần ban hành: 01

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng

Quy định nội dung, thời điểm, phương pháp, ghi nhận, lượng giá và giám sát hoạt động hướng dẫn, tư vấn, giáo dục sức khỏe (GDSK) cho người bệnh và người nhà; áp dụng cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, bác sĩ tại các khoa lâm sàng và Khoa Khám bệnh.

Điều 2. Nguyên tắc

- Đúng – đủ – dễ hiểu – phù hợp; tôn trọng, bảo mật thông tin người bệnh.
- Cá thể hóa theo bệnh lý, độ tuổi, trình độ nhận thức, nguy cơ và khả năng tự chăm sóc; không tư vấn chung chung.
- Mỗi lần tư vấn đều kiểm tra hiểu biết của người bệnh (phương pháp teach-back: yêu cầu người bệnh nhắc lại bằng lời của mình).
- Mọi hoạt động tư vấn, GDSK đều được ghi nhận trong hồ sơ chăm sóc.

Chương II. NỘI DUNG

Điều 3. Thời điểm và nội dung tối thiểu

Thời điểm	Nội dung tối thiểu	Người thực hiện
Khi nhập viện (trong 24 giờ)	Nội quy khoa; quyền và nghĩa vụ người bệnh; phòng ngừa té ngã; cách gọi hỗ trợ; vòng nhận dạng	ĐD tiếp nhận
Trong điều trị	Dùng thuốc (tên, cách dùng, tác dụng phụ cần báo); dinh dưỡng; vận động; chăm sóc theo bệnh lý; phòng biến chứng; trước và sau thủ thuật	ĐD được phân công; bác sĩ giải thích điều trị
Khi bệnh thay đổi	Diễn biến, kế hoạch chăm sóc mới, việc người bệnh và người nhà cần phối hợp	ĐD, bác sĩ
Khi ra viện	Dùng thuốc tại nhà; lịch tái khám; dấu hiệu nguy hiểm cần quay lại viện; chế độ ăn, sinh hoạt	ĐD được phân công

Điều 4. Cá thể hóa

Đối tượng	Nội dung ưu tiên (ví dụ)
Đái tháo đường	Tự tiêm insulin, theo dõi đường huyết, chế độ ăn, chăm sóc bàn chân
COPD, hen	Tập thở, dùng bình xịt, nhận biết đợt cấp
Sau phẫu thuật	Vận động sớm, chăm sóc vết mổ, dấu hiệu nhiễm khuẩn
Người cao tuổi	Phòng té ngã, dùng thuốc an toàn, hỗ trợ người nhà
Thai phụ, sản phụ, trẻ em	Theo tài liệu TTGDSK của Khoa Sản, Khoa Nhi
Người bệnh lọc máu	Theo tài liệu TTGDSK của Bộ phận Thận nhân tạo

Điều 5. Phương pháp và tài liệu

- Tư vấn trực tiếp tại giường là chính; tư vấn nhóm, họp Hội đồng người bệnh; tờ rơi, poster, video, mã QR, màn hình tại khu chờ.
- Tài liệu GDSK dùng chung: Bộ tư vấn – truyền thông GDSK các bệnh thường gặp (bản 2026, 33 chủ đề) và tài liệu TTGDSK của từng khoa trên phần mềm NT Nursing.
- Tài liệu được Phòng Điều dưỡng duyệt trước khi phát hành, rà soát hằng năm; ưu tiên chữ lớn, hình ảnh cho người cao tuổi.
- Mã QR dẫn tới tài liệu GDSK theo bệnh lý được dán tại buồng bệnh (điểm cộng mức 5).

Điều 6. Ghi nhận trong hồ sơ

Mỗi lần tư vấn, GDSK ghi vào phiếu chăm sóc hoặc BM-C6.2-02 đủ 05 yếu tố: (1) nội dung; (2) ngày giờ; (3) người thực hiện; (4) phản hồi của người bệnh, người nhà; (5) kết quả lượng giá hiểu biết. Không ghi chung chung kiểu "đã GDSK".

Điều 7. Lượng giá hiểu biết

Người bệnh được lượng giá bằng BM-C6.2-01 tối thiểu khi ra viện; người bệnh có bệnh mạn tính, dùng thuốc nguy cơ cao, tự chăm sóc tại nhà được lượng giá thêm trong điều trị. Nội dung chưa đạt phải hướng dẫn lại và lượng giá lại trước khi ra viện.

Chương III. GIÁM SÁT, CẢI TIẾN

Điều 8. Giám sát

- Điều dưỡng trưởng khoa: quan sát 02 lượt tư vấn và kiểm tra 05 hồ sơ/tháng bằng BM-C6.2-04.
- Phòng Điều dưỡng: giám sát hằng tháng theo kế hoạch; khảo sát ý kiến người bệnh về GDSK (CKL.GDSK.01) tối thiểu 30 phiếu/khoa/quý.
- Kết quả nhập trên phần mềm NT Nursing; báo cáo tại họp điều dưỡng trưởng tháng.

Điều 9. Cải tiến

Phân tích phản hồi người bệnh và kết quả lượng giá hằng quý để cập nhật tài liệu, phương pháp truyền thông (ví dụ: người bệnh không nhớ hướng dẫn thì bổ sung video, mã QR; người cao tuổi khó đọc thì tăng cỡ chữ, hình ảnh; điều dưỡng quá tải thì dùng video tự động tại khu chờ).

Chương IV. TRÁCH NHIỆM

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện

- Trưởng phòng Điều dưỡng: chỉ đạo, duyệt tài liệu, tổ chức tập huấn, giám sát, tổng hợp chỉ số.
- Điều dưỡng trưởng khoa: phân công, bảo đảm tài liệu GDSK tại khoa, giám sát hằng tháng.
- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên: thực hiện tư vấn, ghi nhận, lượng giá theo SOP-C6.2-01.
- Bác sĩ điều trị: giải thích chẩn đoán, phương pháp điều trị, nguy cơ, lợi ích; phối hợp điều dưỡng khi người bệnh chưa hiểu.

Điều 11. Hiệu lực

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

GIÁM ĐỐC